INFORME DE EVALUACIÓN MIOFUNCIONAL OROFACIAL

Paciente: Sofía Villa Grande
Edad: 11 años
Derivación: Médica otorrinolaringóloga.

1. Anamnesis

Sofía, de 11 años de edad, concurre a evaluación fonoaudiológica por derivación de médica otorrinolaringóloga. La consulta médica inicial se relaciona con la presencia de una voz de tono agudo desde el nacimiento. Según lo referido, no presenta dolor, episodios de pérdida de voz ni antecedentes de uso vocal inadecuado.

En cuanto a los antecedentes de salud, la madre refiere episodios ocasionales de resfríos y mucosidad nasal. No presenta antecedentes quirúrgicos ni recibe medicación actualmente. Concurre a tratamiento psicológico y psicopedagógico. No se refieren antecedentes familiares relevantes.

Respecto de la alimentación, no presenta dificultades para incorporar diferentes consistencias, preferencias alimentarias restrictivas ni dificultades referidas para masticar o ingerir líquidos. No se registran episodios frecuentes de atragantamiento.

En relación con los hábitos orofaciales, utilizó chupete y mamadera hasta aproximadamente los tres años y medio. Actualmente presenta mordisqueo labial y onicofagia.

En cuanto al patrón respiratorio y al descanso nocturno, refiere respirar habitualmente por la nariz. No se reporta respiración bucal durante el sueño, ronquidos, inquietud durante el descanso, sialorrea nocturna, despertares con sequedad bucal ni cansancio al despertar. Los episodios de resfrío no son frecuentes.

En el área de la comunicación, no refiere dificultades para producir los sonidos del habla ni episodios recurrentes de disfonía o pérdida de voz. Realiza hockey como actividad deportiva y no manifiesta dificultades respiratorias durante el ejercicio físico. No presenta alteraciones posturales diagnosticadas.

2. Evaluación muscular orofacial

Se evaluó la musculatura peribucal, lingual y masticatoria.

Musculatura peribucal: los músculos orbiculares de los labios y buccinadores presentan tonicidad conservada.

Musculatura lingual: presenta tonicidad conservada y logra realizar movimientos de elevación, descenso, protrusión y retrusión. Sin embargo, durante su ejecución se observan movimientos cefálicos asociados, con dificultad para disociar los movimientos linguales de los movimientos de cabeza.

Musculatura masticatoria: logra realizar movimientos de apertura, cierre, protrusión y diducción mandibular.

3. Evaluación exobucal

Tipo facial y patrón de crecimiento: presenta facies dentro de parámetros habituales y patrón de crecimiento mesofacial, con leve tendencia a la convexidad del perfil facial.

Labios: ambos labios presentan características morfológicas conservadas. Se observa competencia labial en reposo. La movilidad labial es adecuada, logrando realizar movimientos de fruncimiento, estiramiento, elevación, descenso y lateralización, sin evidenciar contracciones compensatorias de la musculatura perioral durante estas praxias.

Fosas nasales: las narinas presentan tamaño y simetría conservados. No se observa colapso nasal durante la inspiración.

4. Evaluación de la articulación temporomandibular (ATM)

La apertura bucal máxima registrada mediante pie de rey es de **34,5 mm**. Durante la apertura y los movimientos mandibulares evaluados no se observan laterodesviaciones.

5. Evaluación endobucal

Lengua: durante la ejecución de movimientos linguales voluntarios, como afinamiento, retrusión, descenso de la base lingual y protrusión, se observa temblor lingual marcado. Asimismo, persiste la dificultad para disociar los movimientos de la lengua de los movimientos mandibulares.

Paladar duro: presenta una apariencia ligeramente estrecha, con rugas palatinas definidas.

Paladar blando y úvula: presentan características conservadas. La úvula se encuentra centrada.

Encías: sin alteraciones aparentes a la inspección.

6. Evaluación de las funciones orofaciales

Respiración

Se observa un patrón respiratorio de predominio costodiafragmático, con leve participación costal superior. El modo respiratorio observado es nasal.

En la prueba de Rosenthal, la paciente logra respirar por ambas narinas sin dificultad aparente. En la evaluación mediante espejo de Glatzel, se observa una condensación simétrica, con distribución y proyección similares en ambas narinas. En la observación del reflejo nasal de Godin, no se evidencia dilatación significativa de las narinas ni escape nasal.

Los hallazgos obtenidos durante la evaluación funcional resultan compatibles con una permeabilidad nasal conservada en las condiciones del examen.

Deglución

Mediante la **técnica de Payne**, utilizada para explorar la ubicación del contacto lingual durante la deglución, se observa apoyo de los bordes laterales de la lengua en las regiones correspondientes a caninos y premolares de ambos lados, así como contacto con los incisivos centrales. Estos hallazgos evidencian una **posición lingual anteriorizada durante la función deglutoria**.

Deglución de alimentos sólidos: presenta masticación bilateral y adecuada formación del bolo alimenticio. Durante la masticación se observa apertura bucal ocasional. En algunas oportunidades, luego de iniciar la deglución, vuelve a introducir alimento en la boca, lo que sugiere la necesidad de continuar observando la coordinación y finalización de la secuencia masticatoria-deglutoria. Durante la deglución se evidencia apertura bucal compensatoria, contracción de la musculatura peribucal y presencia de restos alimenticios sobre la superficie lingual.

Deglución de saliva: se observa contracción de la musculatura peribucal, especialmente de la musculatura labial, con esfuerzo aumentado para lograr el sellado de los labios.

Deglución de líquidos: se evidencia participación compensatoria de la musculatura peribucal, con marcada acentuación del surco nasogeniano durante la ejecución.

En conjunto, se observan compensaciones musculares periorales durante la deglución de saliva, líquidos y alimentos, con mayor esfuerzo para el sellado labial.

Masticación

Presenta masticación bilateral, con movimientos rotatorios adecuados y buena formación del bolo alimenticio. Se observa apertura bucal ocasional durante el proceso masticatorio. Asimismo, se registra la reintroducción de alimento en la cavidad oral luego de haber iniciado la deglución, aspecto que requiere seguimiento clínico para determinar su frecuencia y posible repercusión funcional.

Postura

Durante la evaluación, la paciente mantiene una postura general erguida y adecuada, sin alteraciones posturales evidentes en las condiciones de observación.

Fonoarticulación

Se administró una lista de palabras para explorar la producción de los sonidos del habla. Se observa una organización fonológica conservada, con puntos articulatorios adecuados y sin distorsiones sistemáticas. Como hallazgo puntual, se registra dificultad en la vibración correspondiente al fonema /r/ vibrante múltiple en algunas palabras.

7. Conclusión

La evaluación miofuncional orofacial de Sofía Villa Grande evidencia un modo respiratorio nasal, con patrón respiratorio de predominio costodiafragmático y sin signos clínicos manifiestos de dificultad en la permeabilidad nasal durante las pruebas realizadas.

En el examen muscular se observa tonicidad conservada de la musculatura peribucal y lingual, junto con dificultades en la disociación de los movimientos linguales respecto de los movimientos cefálicos y mandibulares. Se registra, además, temblor lingual durante la ejecución de determinadas praxias.

En relación con las funciones orofaciales, se identifica una posición lingual anteriorizada durante la exploración del contacto lingual para la deglución, asociada a compensaciones de la musculatura peribucal y labial durante la deglución de saliva, líquidos y alimentos. También se observa apertura bucal ocasional durante la masticación y presencia de restos alimenticios sobre la lengua luego de la deglución.

En el área fonoarticulatoria, la producción de los sonidos del habla se encuentra globalmente conservada, con dificultad puntual para lograr la vibración de la /r/ vibrante múltiple en algunas palabras.

En función de los hallazgos, se considera pertinente realizar seguimiento fonoaudiológico de las funciones orofaciales, especialmente de la coordinación y disociación lingual, el patrón deglutorio y las compensaciones musculares observadas. Asimismo, se recomienda complementar la valoración de la voz, motivo de la derivación otorrinolaringológica, mediante una evaluación vocal específica que permita caracterizar el tono agudo referido y determinar la necesidad de intervención.

8. Objetivos terapéuticos sugeridos

- Favorecer la disociación de los movimientos linguales respecto de los movimientos mandibulares y cefálicos.
- Mejorar el control motor y la precisión de los movimientos linguales voluntarios.
- Promover una adecuada ubicación lingual durante la deglución.
- Disminuir las contracciones compensatorias de la musculatura peribucal durante la deglución de saliva, líquidos y alimentos.
- Favorecer el sellado labial funcional, evitando esfuerzos musculares innecesarios.
- Optimizar la coordinación de las secuencias masticatoria y deglutoria.
- Favorecer una deglución eficiente, con adecuada limpieza de la cavidad oral posterior al acto deglutorio.
- Evaluar la producción de la vibrante múltiple /r/ y determinar la necesidad de abordaje específico.
- Caracterizar las particularidades vocales de la paciente mediante evaluación específica y establecer objetivos de intervención en función de los resultados.

9. Orientaciones

- Favorecer una postura estable y erguida durante las comidas.
- Promover una masticación tranquila, con los labios cerrados cuando sea posible y sin forzar el sellado.
- Verificar que haya finalizado la deglución y que no queden restos de alimento en la cavidad oral antes de introducir un nuevo bocado.
- Evitar corregir mediante esfuerzos exagerados de labios o mentón; priorizar movimientos funcionales y coordinados.
- Registrar la evolución de los hábitos de mordisqueo labial y onicofagia para considerar su abordaje dentro del tratamiento.
- Mantener el seguimiento con otorrinolaringología por el motivo vocal inicial y complementar la evaluación fonoaudiológica de la voz según criterio clínico.

INFORME DE EVALUACIÓN MIOFUNCIONAL OROFACIAL

Nombre y apellido: Sofía Villagrante
Edad: 11 años
Institución educativa: Martín Rodríguez
Profesional derivante: Dra. Laura Villalta – Otorrinolaringología
Profesional evaluadora: Lic. Julieta Barrera – M.P. 7353
Fecha de evaluación: ____ / ____ / _____

1. MOTIVO DE CONSULTA

Sofía concurre a evaluación fonoaudiológica por derivación de la Dra. Laura Villalta, médica otorrinolaringóloga, debido a la presencia de una voz de tonalidad aguda desde el nacimiento, que persiste en la actualidad. Según refiere su madre, esta característica vocal no se acompaña de dolor, pérdida de voz ni esfuerzo vocal manifiesto.

2. ANAMNESIS

Antecedentes de salud

La madre refiere que Sofía presenta episodios ocasionales de resfríos y secreciones nasales. No informa otros antecedentes de salud de relevancia. No presenta antecedentes quirúrgicos ni recibe medicación habitual. Actualmente, concurre a seguimiento con profesionales de psicología y psicopedagogía. No se refieren antecedentes familiares de relevancia.

Alimentación

No se identifican dificultades en la incorporación de nuevas consistencias ni selectividad alimentaria significativa. Presenta preferencias alimentarias variadas, no evita alimentos que requieren mayor masticación y no se registran episodios frecuentes de atragantamiento.

Hábitos orofaciales

Se informa el uso de mamadera y chupete hasta los tres años y medio. Actualmente, presenta mordisqueo labial y onicofagia.

Respiración y sueño

Según lo referido en la anamnesis, Sofía respira por la nariz durante el día, aunque duerme con la boca abierta. No se informan ronquidos, episodios de apnea observados, sueño inquieto, babeo sobre la almohada, sequedad bucal al despertar ni cansancio al levantarse.

Habla, actividad física y postura

No se refieren dificultades en la pronunciación de los sonidos del habla. Practica hockey y no manifiesta dificultades respiratorias durante la actividad física ni cansancio fácil. No utiliza plantillas y no presenta alteraciones posturales diagnosticadas.

3. EVALUACIÓN MIOFUNCIONAL OROFACIAL

3.1. Examen muscular

Musculatura peribucal: se evalúan los músculos orbiculares de los labios y los buccinadores. Se observa tonicidad y movilidad conservadas, con ejecución adecuada de los movimientos solicitados.

Musculatura lingual: se exploran los movimientos de elevación, descenso, protrusión y retrusión. Sofía logra ejecutar los movimientos solicitados, con tonicidad conservada. Sin embargo, durante algunos movimientos, especialmente la elevación y la protrusión lingual, se observa acompañamiento con movimientos cefálicos, lo que evidencia dificultad en la disociación de los movimientos linguales respecto de la musculatura cervical.

Musculatura masticatoria: realiza adecuadamente los movimientos de apertura, cierre, protrusión y lateralidad mandibular.

3.2. Examen extraoral

Facies y perfil: presenta facies de características generales conservadas y perfil levemente convexo. El patrón de crecimiento facial se aprecia adecuado según la observación clínica.

Labios: ambos labios presentan características morfológicas conservadas y competencia labial en reposo. La movilidad labial se encuentra preservada, con ejecución adecuada de los movimientos de fruncimiento, estiramiento, elevación, descenso y lateralización. No se observa contracción perioral marcada durante las praxias examinadas. Se aprecia un surco nasogeniano levemente marcado.

Frenillos labiales: los frenillos labiales superior e inferior presentan características clínicas conservadas.

Nariz y narinas: se observan narinas simétricas, de características morfológicas conservadas y acordes con las proporciones de las estructuras orofaciales. No se evidencia colapso alar durante la inspiración.

Articulación temporomandibular (ATM): se registra una apertura bucal de 34,5 mm, medida con calibre tipo pie de rey, sin laterodesviaciones observables durante el movimiento.

3.3. Examen endobucal

Lengua: presenta tamaño y movilidad general conservados. No se observan signos clínicos evidentes de acortamiento del frenillo lingual. Sin embargo, se identifica dificultad para disociar los movimientos linguales de los mandibulares y un leve temblor durante la ejecución de determinadas praxias.

Paladar óseo: se observa un paladar de configuración ligeramente estrecha, con rugas palatinas definidas.

Paladar blando y úvula: presentan características morfológicas conservadas a la inspección clínica.

Encías: se observan de características clínicas conservadas.

3.4. Evaluación respiratoria

Se observa un patrón respiratorio predominantemente costo-diafragmático, con participación y elevación leve del tórax durante la inspiración.

El modo respiratorio observado es nasal. Durante la evaluación del reflejo narinario de Godin no se evidencia dilatación significativa de las narinas. En la prueba con espejo de Glatzel se observa simetría en la condensación y la proyección del flujo aéreo nasal. La prueba de Rosenthal se realiza sin dificultad aparente para respirar por ambas narinas.

Estos resultados describen el desempeño respiratorio durante las pruebas realizadas y no descartan, por sí solos, posibles alteraciones de la permeabilidad nasal durante el sueño.

3.5. Evaluación de la deglución

Técnica de Payne: se utiliza como procedimiento exploratorio para identificar los puntos de contacto lingual durante la deglución. Se observa participación de los bordes laterales de la lengua, con apoyo en la región correspondiente a primeros premolares, caninos e incisivos laterales, así como contacto anterior de la punta lingual sobre los incisivos centrales.

Deglución de sólidos: se observa apertura bucal durante la ejecución, múltiples aperturas de la boca a lo largo de la secuencia masticatoria y deglutoria, e interposición lingual a nivel dentario. Se identifica un leve empuje lingual anterior.

Deglución de líquidos: se evidencia contracción de la musculatura peribucal durante el acto deglutorio.

Patrón deglutorio: durante la deglución se observa una configuración labial en sonrisa, acompañada de interposición lingual a nivel dentario. Se registran múltiples aperturas bucales durante la masticación y la deglución. No se observan compensaciones faciales ni corporales marcadas durante el acto deglutorio.

Masticación: presenta un patrón masticatorio bilateral, con adecuada elaboración del bolo alimenticio y movimientos mandibulares alternados y rotatorios.

Postura durante la alimentación: mantiene una actitud postural erguida y adecuada durante las tareas observadas.

3.6. Evaluación fonoarticulatoria

Se explora la producción del habla mediante la repetición de listas de palabras, sílabas y oraciones.

En las producciones evaluadas, se observa ausencia o disminución de la vibración correspondiente al fonema /r/ vibrante. El resto de las producciones exploradas presenta una organización fonológica adecuada, sin distorsiones articulatorias evidentes en las tareas realizadas.

3.7. Consideraciones sobre la voz

La presencia de una voz de tonalidad aguda persistente desde el nacimiento constituye el motivo principal de consulta, según lo referido por la familia. Durante la anamnesis no se informan dolor, pérdida de voz ni esfuerzo vocal manifiesto.

La caracterización de las cualidades vocales y la determinación de su posible origen requieren una evaluación vocal específica, junto con la integración de los hallazgos de la valoración otorrinolaringológica.

4. SÍNTESIS DE LOS HALLAZGOS

En la evaluación miofuncional orofacial de Sofía se observan estructuras peribucales de características generales conservadas, competencia labial en reposo y movilidad labial adecuada. No se identifican signos clínicos evidentes de acortamiento del frenillo lingual.

En el examen muscular se observa dificultad para disociar los movimientos linguales de los mandibulares y cefálicos, con leve temblor durante algunas praxias. Se registra un paladar óseo ligeramente estrecho.

En relación con la función respiratoria, las pruebas realizadas muestran un modo respiratorio nasal durante la evaluación clínica, sin signos evidentes de colapso alar y con resultados simétricos en la prueba con espejo de Glatzel. No obstante, se destaca como antecedente la postura de boca abierta durante el sueño.

En la evaluación de la deglución se identifican interposición lingual a nivel dentario, configuración labial en sonrisa y múltiples aperturas bucales durante la secuencia masticatoria y deglutoria. Asimismo, se observa contracción peribucal durante la deglución de líquidos y un leve empuje lingual anterior durante la deglución de sólidos. No se evidencian compensaciones faciales ni corporales marcadas. La masticación presenta un patrón bilateral, con adecuada elaboración del bolo y movimientos mandibulares alternados y rotatorios.

En el área fonoarticulatoria se observa una alteración en la producción vibrante del fonema /r/, sin otras distorsiones evidentes en las producciones examinadas.

Finalmente, la persistencia de una voz de tonalidad aguda constituye el motivo principal de consulta y requiere una evaluación vocal específica para caracterizar sus particularidades y determinar las necesidades de intervención.

5. ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES

* Realizar una evaluación específica de la función vocal, contemplando las características perceptuales y acústicas de la voz, la frecuencia fundamental, la calidad vocal, la resonancia y el comportamiento fonatorio.
* Integrar los resultados de la evaluación vocal con la valoración otorrinolaringológica para determinar la necesidad de estudios complementarios y orientar el abordaje correspondiente.
* Considerar intervención miofuncional orientada a favorecer la disociación lingual, la coordinación de los movimientos orofaciales y la adecuación del patrón deglutorio, de acuerdo con los objetivos terapéuticos que se establezcan.
* Abordar la producción del fonema /r/ mediante una exploración articulatoria específica y estrategias terapéuticas acordes con las características observadas.
* Considerar el antecedente de respiración con boca abierta durante el sueño y realizar seguimiento de la función respiratoria en coordinación con el equipo de salud, si corresponde.

Se extiende el presente informe a los fines de dejar constancia de los hallazgos obtenidos durante la evaluación fonoaudiológica.

Lic. Julieta Barrera
Licenciada en Fonoaudiología – M.P. 7353

Firma y sello: _____

Fecha: ____ / ____ / _____